HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Formation : Infirmier Organisateur de l'Accueil - Perfectionnement

G. SILVETTI
M. LAFI

Sommaire

1. IOA : Rappel du rôle et des missions
2. Rappels médico-légaux
3. Table ronde

1. IOA : Rappel du rôle et des missions

IOA : Mes missions

La mission générale de l'IOA définie dans le référentiel de la SFMU est d' ***« Accueillir de façon personnalisée le patient et ses accompagnants à leur arrivée, définir les priorités de soins en fonction des besoins exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du lieu de soins adapté. Ces actions ont pour objectif d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et de leurs accompagnants dès l'accueil. Elles sont menées en lien constant avec le médecin référent chargé de superviser le fonctionnement du service et la gestion des flux. »***

1. **Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences**
2. **Décider du lieu de soins adapté**
3. **Installer**
4. **Informer, aider, rassurer**
5. **Surveiller**
6. **Anticiper**
7. **Communiquer et coordonner**
8. **Enseigner**

IOA : Mes missions

Accueillir, évaluer et procéder à un tri des patients arrivant aux urgences

L'IOA accueille = soin relationnel auprès du patient.
→ Objectif : permettre de comprendre et d'accepter les soins dans les meilleures conditions :
→ gestion du stress, information, écoute, installation, confort, prise en charge de la douleur

l'IOA évalue rapidement le degré d'urgence afin de privilégier la prise en charge du patient présentant un caractère réel d'urgence.

Le tri doit s'effectuer à partir d'outils spécifiques utilisés dans le service (Échelle de tri comme la FRENCH) et sur des protocoles écrits et signés par le responsable médical

L'IOA identiafie les besoins et les ressources dont le patient aura besoin.

L'IOA s'inscrit dans la démarche diagnostique infirmière, qui est partie intégrante du rôle propre infirmier.

IOA : Mes missions

Décider du lieu de soins adapté

L'IOA décide du lieu de soins approprié à l'état du patient, après recueil et synthèse des informations.
→ enfant/adulte
→ traumatologie/non traumatologie
→ valide/couché
→ malade stable/instable
→ consultation sans/avec acte
→ niveau de tri

Celles-ci sont obtenues par un examen clinique (entretien, examen physique et paramètres vitaux) et la connaissance de tous documents en possession du patient.

IOA : Mes missions

Installer

L'IOA installe ou fait installer le patient en fonction de ses besoins
→ chaise, brancard...
→ protection (froid)
→ confort (position antalgique)

IOA : Mes missions

Informer, aider, rassurer

L’IOA informe le patient et ses accompagnants de l'organisation des soins, du fonctionnement du service, du délai et des raisons d'une attente éventuelle.

L’IOA rassure les familles et les informe des soins en cours et à venir, de l’attente des examens de laboratoire et/ou d’imagerie.

L’IOA est en relation permanente avec les médecins et infirmier(e)s effectuant les soins des différentes zones.

IOA : Mes missions

Surveiller

L'IOA assure la surveillance régulière de la salle d'attente, coordonne les informations destinées aux accompagnants et aux familles, apaise au mieux les tensions afin de prévenir toutes formes de violences.

L'IOA est amené(e) à surveiller les salles d'attentes des patients en attente de prise en charge médicale.

IOA : Mes missions

Anticiper

L'IOA *peut* assurer une liaison directe avec les centres de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers, les centres de réception et de régulation des appels du SAMU, la police et anticipe la venue des patients à risque (détenus, patient consultant sur réquisition judiciaire...).

IOA : Mes missions

Communiquer et coordonner

Pour favoriser une bonne communication et essayer d'apaiser au mieux les craintes et/ou angoisses des accompagnants, l'IOA centralise les informations, localise les patients afin de pouvoir répondre à toute demande.

Les familles doivent, par sa présence et ses informations, trouver un(e) interlocuteur(trice) référent(e) performant(e).

IOA : Mes missions

Enseigner

Dans le contexte spécifique de l'accueil et du tri dans un service d'urgences,

L'IOA encadre les étudiants infirmiers en stage et les infirmier(e)s en stage d'intégration.

Il est important de souligner que l'IOA assure la formation pratique des nouveaux infirmiers qui auront, à la suite d'une formation spécifique, la possibilité d'assurer cette fonction.

3Q2C

Outil permettant de réaliser l'interrogatoire clinique

QUI	Age, Sexe, ATCD, épisodes similaires, TTT Spécifiques
QUOI	Motif (attention peut être différent à l'arrivée)
QUAND	Date et heure de début
COMMENT	Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution
COMBIEN	Intensité du symptômes, pics, évolution

IOA

Exemple d'un recueil IOA

Qui ?	Me W, 31 ans.
Quoi ?	Patiente vient pour douleurs au niveau de l'hypochondre droit.
Comment ?	Douleur d'apparition brutale ce jour vers 18h, avec nausées sans vomissements. Pas de SFU, pas de troubles du transit associés.
Quand ?	DDR : Il y a 2 semaines, patiente sous contraception et pas de risque de grossesse.
Combien ?	A l'IOA, douleurs présente, intensifié à la palpation, sans irradiation. Abdomen souple. Présente des nausées.

IOA : Points clefs

1 Accueil

Présentation (prénom, fonction, intérêt de l'évaluation, variation ordre de passage : temps d'attente environ)

→ **information indispensable** = acceptation de l'attente + diminution de l'anxiété.

= Soins relationnel, relation de confiance.

2 Analyse

Examen clinique infirmier :

Examen physique (5 sens – Ø goût).

- Vue
- Toucher
- Odorat
- Ouïe

3 Entretien

Entretien : 3Q2C

- Qui ?
- Quoi ?
- Quand ?
- Comment ?
- Combien ?

Paramètres vitaux :

- FC
- TA
- SpO2
- FR
- Température
- Douleur

4 Décision

Décision du niveau de tri & choix de la zone de soins en fonction des éléments recueilli et des critères de gravité ou non du patient

→ Grille de tri

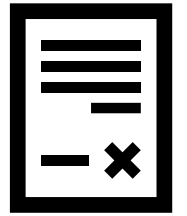
Protocole & Procédure

Protocoles :



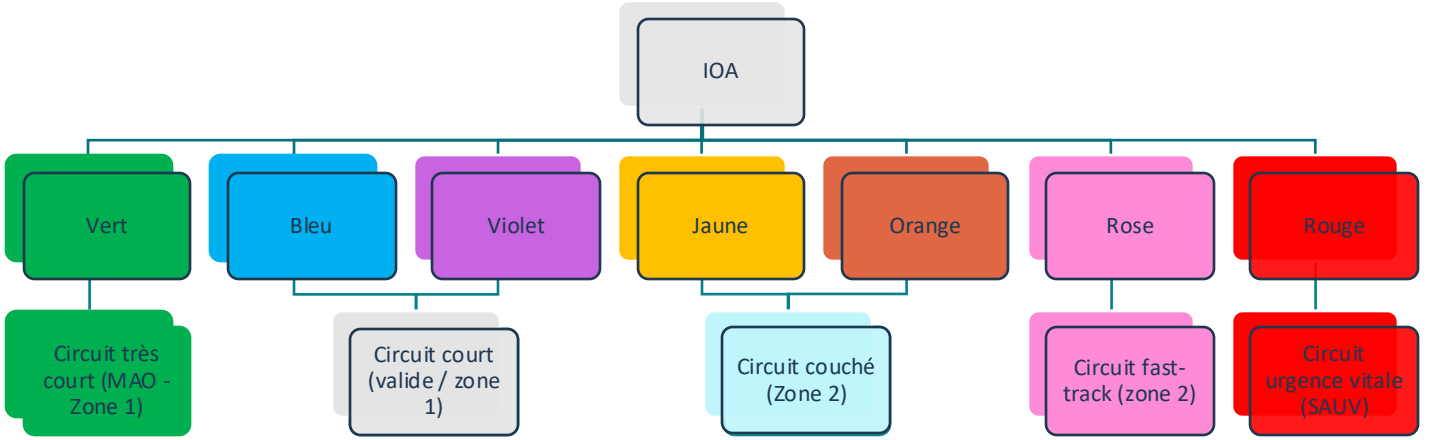
- Protocole ECG
- Protocole Douleur
- Protocole Hypo/Hyperkaliémie
- Protocole radio anticipé
- Protocole gestion des stupéfiants

Procédures :



- Prise en charge du mineur
- Fugue / sortie à l'insu du service
- Certificat de Non-Admission
- Patients ayant des troubles cognitifs
- Patients ayant des troubles psychiatriques
- Ebriété
- Conduite à tenir en cas de non-réponse à l'appel
- Procédure d'accueil d'enfants de moins de 16 ans

Le tri IOA



Zone Valide = Zone 1

Violet : Prise en charge immédiate
Bleu : Prise en charge médicale.
Vert : circuit particulier – PEC 1H30 début/fin.

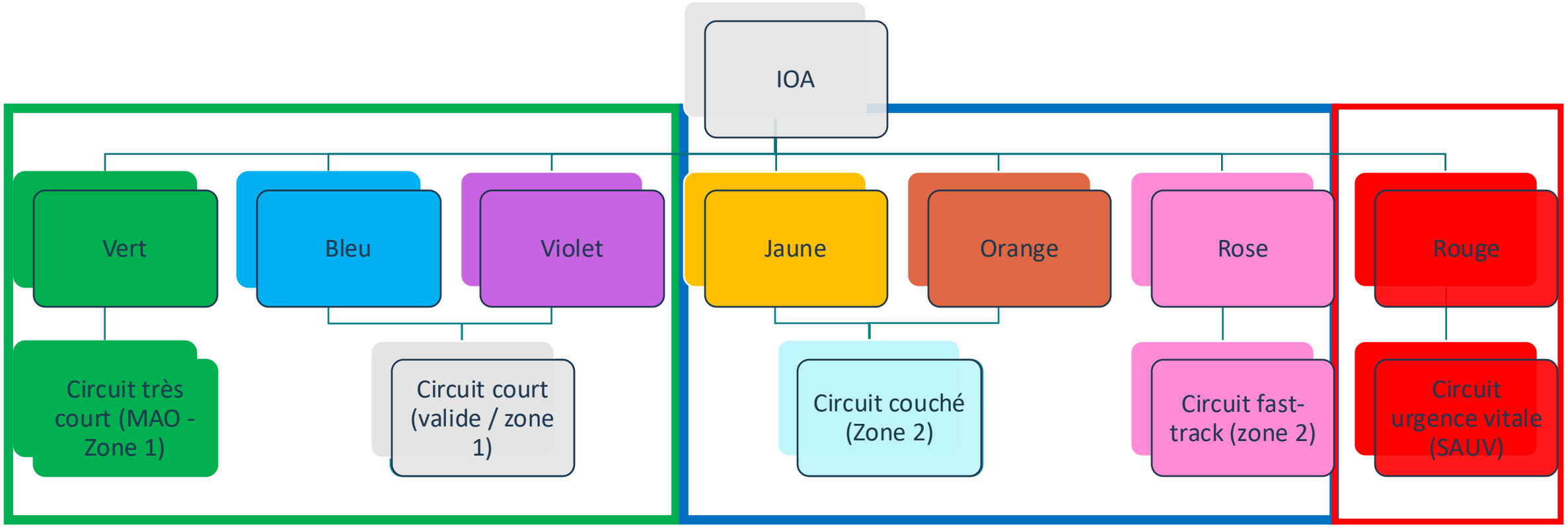
Zone couchée = Zone 2

Orange : Prise en charge médicale < 60 min
Jaune : Prise en charge médicale < 90 min
Rose : Fast Track (prise en médicale < 60 min + PEC dans le service < 2h)

SAUV

Rouge : Prise en charge immédiate

Les différents tris et circuits



Médi-mémo

Malaise :

Avec ou sans prodromes

→ Soins obligatoires : ECG + HGT

Douleur thoracique :

Type ; Irradiation ; Localisation ; H de début ; continue ou discontinue ; arrivée à l'effort ou au repos ; brutale ou progressive : dyspnée associée.

→ ATTENTION AU FACTEURS DE RISQUE (Tabac, cholestérol, surpoids) / ATCD Familiaux.

→ Soins obligatoires : ECG + TA aux 2 bras

AVC / AIT :

Déficit < 4h30 = déficit moteur et/ou sensitif, trouble du langage, trouble de la vision, vertiges.

→ Soin obligatoire : HGT (Hypoglycémie = diagnostic différentiel).

→ Décubitus 0° + TA aux 2 bras.

Douleurs abdominales :

SFU, Transit, DDR, Abdomen souple/tendu, douleur à la palpation, N/V, irradiation

→ BU (…)

1-MALAISE

Avec prodromes : vertiges, douleur, nausées, bourdonnements d'oreilles…
Sans prodromes : **SYNCOPE** = patient scopé
Autres : TC, PC, Douleur thoracique
Soins particuliers: **ECG pour tous**, dextro

2-DOULEUR THORACIQUE

Type : pique, pince, serre, brûle…
Irradiation : bras, mâchoire, dos…
Autres : Localisation, présente à l'IOA, heure de début, durée, arrivée à l'effort ou au repos, continue ou discontinue, dyspnée associée, installation brutale ou progressive.
Facteurs de risque : Tabac, cholestérol, HTA, dyslipidémie, Diabète, Surpoids.
ATCD familiaux : IDM < 60ans
Soin particulier: **ECG**

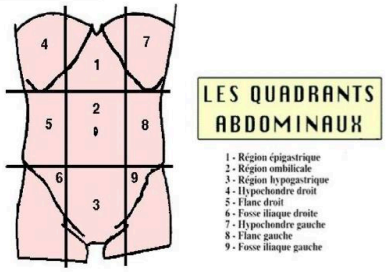
3-AVC-AIT

Alerte thrombolyse : Déficit <4h30
- AVC constitué
- AVC du réveil
- AIT

Symptômes :
Déficit moteur, sensitif, troubles du langage, troubles de la vision, pupilles symétriques et réactives, vertiges (type)
Soins (Hors alerte thrombolyse) :
Décubitus, Tension, Saturation, Pouls, Température, Dextro, Glasgow, Déshabillage
Soins (Alerte thrombolyse):
Idem + Décubitus 0° strict, Tension aux deux bras

4-DOULEUR ABDOMINALE

SFU : Brulures mictionnelles, Hématurie
Transit : Gaz ? Selles ? Diarrhées ?
Autres : Date des dernières règles, abdomen souple, tendu, douloureux à la palpation, nausées, vomissements, irradiation lombaire…
Localisation :



Soin particulier : BU

Médi-mémo

Dyspnée :
Signes de lutte respiratoire
Autres signes de détresse (marbrures, cyanose,…)
→ Soins : Saturation + Fréquence respiratoire

Crise d'asthme :
Nombre, durée, observance TTT
Signe de lutte, difficulté à la parole
→ ATCD d'hospitalisation en réanimation
→ Soins : Saturation + Fréquence respiratoire + PEAKFLOW

Vertiges :
Types, positionnels ou pas, N/V, suite TC
Eliminer AVC/AIT : appel MAO si vertiges < 4h30

Saignements:
Localisation, quantité, actif ou non, avec/sans ATC/AAP, signes associés
→ Hémocue, FR.

5-DYSPNEE	6-CRISE D'ASTHME
Signes cliniques : - Signes de lutte respiratoire (tirage, balancement thoraco-abdominal, battement des ailes du nez, polypnée, bradypnée…) - Autres : Marbrures, difficultés à la parole, cyanose, sueur, douleur thoracique associée… ATCD : BPCO (saturation de base), Asthme Soins particuliers : Saturation, Fréquence respiratoire	Nombres de crises, depuis combien de temps, observance du traitement, difficultés à la parole, signes de lutte respiratoire, hospitalisé en réanimation pour crise d'asthme Soins particuliers : Saturation, Fréquence respiratoire, **Peakflow** (valeur de référence)
7-VERTIGES	**8-SAIGNEMENTS**
Eliminer AVC/AIT Appel MAO si vertiges < 4h30 Types (rotatoires, qui tanguent), positionnels ou pas, nausées/vomissements, suite TC	Localisation : méléna, hématurie, hématémèse, hémoptysie,… Autres : quantité, actif ou non, durée, avec ou sans ATC/AAP Signes associés : marbrures, dyspnée, pâleur… Soin particulier : Hemocue, FR

Médi-mémo

TC :
PC, N/V, Vertiges, Tb vision, signes neuro, ATC/AAP
→ Glasgow

Trauma :
Déformation, raccourcissement de membre, plaie, M/S, pouls, couleur, chaleur.
→ TRC

Plaie :
Localisation, suturable ?, saignement actif ?, VAT
→ Nettoyage, pansement humide, xylocaïne.

AVP :
Cinétique, ceinture, airbag, casqué, PC initiale, amnésie des faits, TC, surveillance trauma abdo et thoracique, douleur rachis/cervicale, signes neuro
→ Hémocue, BU si nécessaire

HGT :
Vertiges, vomissements, malaise, diabétique, convulsions, Tb neuro, Tb du comportement
Si dextro > 3g → Cétonémie

9-TRAUMA CRANIEN	10-TRAUMA
Signes cliniques : Perte de connaissance (durée), nausées/vomissements, vertiges, troubles de la vision, signes neurologiques, ATC/AAP Soin particulier : Glasgow	Signes cliniques : Déformation, raccourcissement de membre, plaie ouverte, mobilité, sensibilité, pouls du membre en aval, couleur, chaleur
11-PLAIE	**12-AVP**
Localisation, suturale, taille, saignement actif, depuis combien de temps, mobilité, sensibilité, allure (écoulement, corps étranger…), **VAT** Soins particulier : détersion, pansement humide provisoire, xylocaïne	Cinétique (vitesse), ceinture, airbag déclenché, casqué, état du véhicule et du casque, PC initiale, amnésie des faits, TC, surveillance trauma abdominale et thoracique, douleur rachis, signes neurologiques Soins particuliers : Hemocue, BU si nécessaire
13-DEXTRO	**14-CETONEMIE**
Pour tout patient si : vertiges, vomissements, malaise, diabétique, convulsions, troubles neurologiques, troubles du comportement	Pour tout dextro supérieur à 3g

Médi-mémo

Céphalée :

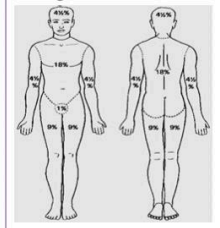
Localisation, installation brutale / progressive
« Coup de tonnerre » , type (pulsatile, continue).
Penser au critère : habituelle et/ou inhabituelle

Brulures :

Localisation, surface, profondeur, inhalation de fumée

→ Plusieurs degrés (3).
→ Evaluation de la surface de la peau (règle des 9 de Wallace).
→ Soins. : refroidir la zone

Si brûlure électrique : rechercher point entrée/sortie + ECG

15-CEPHALEES	16-BRULURES
Siège : hémicrânie, pariétal, occipital Installation brutale ou progressive **Rappel :** « Coup de tonnerre » = céphalée brutale Type : pulsatile, continue	Localisation, surface, profondeur, inhalation de fumée, dyspnée, présence de suie dans les voies aériennes Brûlure de 1er degré : Douleur, Erythème, Coup de soleil Brûlure de 2e degré superficiel : Douleur intense, Aspect rosé, Phlyctène, Suintement Brûlure de 2e degré profond : Douleur faible, Aspect rosé et blanc, Anesthésie partielle, Phanères adhérents Brûlure de 3e degré profond : Absence de douleur, Aspect cartonné, Anesthésie complète, Phanères non adhérents Evaluation de la surface corporelle brûlée : La règle des 9 de Wallace :  Soins particuliers : Refroidir le zone Brûlures éléctriques : rechercher le point d'entrée et de sortie, **ECG**

Grille de tri

ROUGE

Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- ACR
- Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)
- FC > 140 ou FC < 45
- Douleur thoracique avec modification ECG
- TAS > 220mmHg symptomatique
- Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères.

RESPIRATOIRE
- FR < 10
- SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22
- Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%
- Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée

NEUROLOGIQUE
- Coma avec score de Glasgow < 9
- **Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)**

DIGESTIF
- Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)

INFECTIOLOGIE
- Hypothermie avec **modification ECG**

INTOXICATION quelle que soit la nature
- **Avec modification ECG**

MÉTABOLIQUE
- Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5
- Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3
- Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG
- Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG

TRAUMATOLOGIE
- Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils)
- Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place
- Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL – tête – périnée
- Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical
- Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO

PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
- ACR
- Coma

ORANGE

Patient alité présentant une constante d'alerte ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgente

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- Syncope sans prodromes *(À SCOPER)*
- Association de 2 critères suivants : *(À SCOPER)*
  - PAS ≤ 100 mmHg
  - Polypnée ≥ à 22/min
  - Trouble des fonctions supérieures (confusion, désorientation, Glasgow < 15)
- Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG *(À SCOPER)*
- TAS > 220mmHg non symptomatique

RESPIRATOIRE
- FR > 30/min *(À SCOPER hors crise d'angoisse)*
- Ou Signes de lutte respiratoire *(À SCOPER)*

NEUROLOGIQUE
- Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 - 14
- > 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) *(À SCOPER)*

INFECTIOLOGIE
- Hyperthermie > 39°C

INTOXICATION quelle que soit la nature
- Glasgow < 15 et > 9

MÉTABOLIQUE
- Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15
- Hyperkaliémie > 6 mmol/L sans modification ECG

TRAUMATOLOGIE
- Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire)
- Plaie du scalp de grande taille très hémorragique **après accord du MAO**

DOULEUR
- EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN)
- EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Oxynorm

JAUNE

Patient alité mais ne présentant ni signe de gravité, ni d'urgence

ROSE

Fast Track Zone non valide

- Rétention aigue d'urine
- **Déficit neurologique constitué ou transitoire de + de 6h et – de 24h.**
- Mono traumatisme de membre hors tronc
- Traumatisme **bassin/hanche** de la personne âgée
- **TC sans signe** de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant)**.
- Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères** augmentés.
- Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
- Anémie **sans autres anomalies** (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
- Mauvaise évolution d'un **ulcère suivi au GHPSJ**
- Colique néphrétique hyperalgique
- Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable,**
- IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
- Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
- Douleur abdominale du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- Douleur thoracique atypique du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- **FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :**
  - **+ de 75 ans, sans problème sociaux**
  - **Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.**

VIOLET

Patient valide présentant un des motifs suivants :

- Crise d'asthme
- Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive
- Douleur des organes génitaux externe (OGE).
- Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique) ou **CPU psychiatrique**.
- Patient arrivant avec un diagnostic chirurgical **avéré**
- Patient adressé des urgences gynécologiques
- Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation)

BLEU

Patient valide ne présentant ni signes de gravité, ni d'urgence

- Plaies
- Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation)
- Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)
- Patient nécessitant un avis spécialisé

VERT

Patient valide (avec un objectif de qualité institutionnelle de prise en charge ≤ à 1h30)

- Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées
- AES
- CNA
- Panaris collecté isolé
- Consultation simple ne pouvant être réorientée
- Patient reconvoqué (par les urgences) pour une simple consultation/ordonnance

Tri Rouge

ROUGE

Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate

CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE
- ACR - Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités) - FC > 140 ou FC < 45 - Douleur thoracique avec modification ECG - TAS > 220mmHg symptomatique - Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères.
RESPIRATOIRE
- FR < 10 - SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22 - Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94% - Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée
NEUROLOGIQUE
- Coma avec score de Glasgow < 9 - **Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)**
DIGESTIF
- Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique)
INFECTIOLOGIE
- Hypothermie avec **modification ECG**
INTOXICATION quelle que soit la nature
- **Avec modification ECG**
MÉTABOLIQUE
- Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5 - Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3 - Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG - Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG
TRAUMATOLOGIE
- Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils) - Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place - Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL – tête – périnée - Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical - Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO
PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique
- ACR - Coma



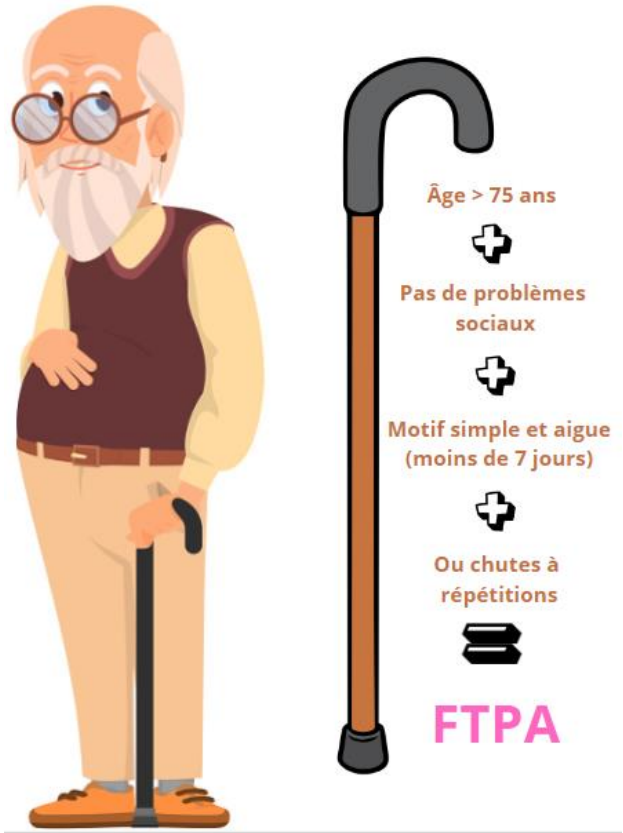
HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Tri rose

ROSE

Fast Track Zone non valide

- Rétention aigue d'urine
- **Déficit neurologique constitué ou transitoire de + de 6h et – de 24h.**
- Mono traumatisme de membre hors tronc
- Traumatisme **bassin/hanche** de la personne âgée
- **TC sans signe** de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant)**.
- Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères** augmentés.
- Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
- Anémie **sans autres anomalies** (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
- Mauvaise évolution d'un **ulcère suivi au GHPSJ**
- Colique néphrétique hyperalgique
- Ebriété sur la voie publique, **Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**
- IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
- Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
- Douleur abdominale du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- Douleur thoracique atypique du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- **FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :**
  - **+ de 75 ans, sans problème sociaux**
  - **Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.**



Douleur

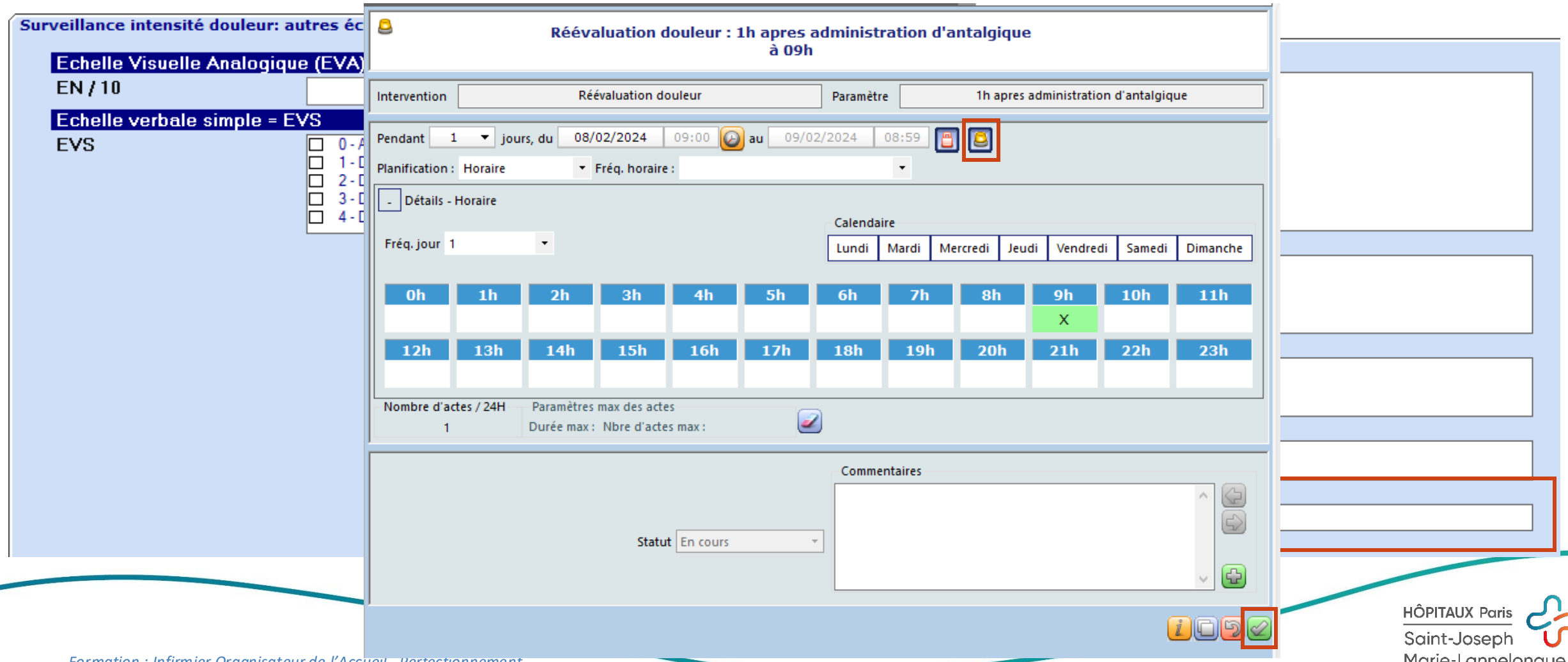
Plusieurs échelles :
- EVA (avec réglette).
- EN
- EVS
- Algoplus
- Doloplus

EN 0 à 4 = ATG palier I (Doliprane®)
EN 5 à 8 = ATG palier I + III (Doliprane® + Oxynormoro®)
EN > 8 = Titration morphine

Douleur = critère de gravité
Donc si administration : ATG palier I + III = Orange (si allongée)

Douleur = Critère HAS = critère certification = Réévaluation obligatoire entre 45min et 2h
Prescription de la réévaluation dès l'IOA, ou à chaque administration.

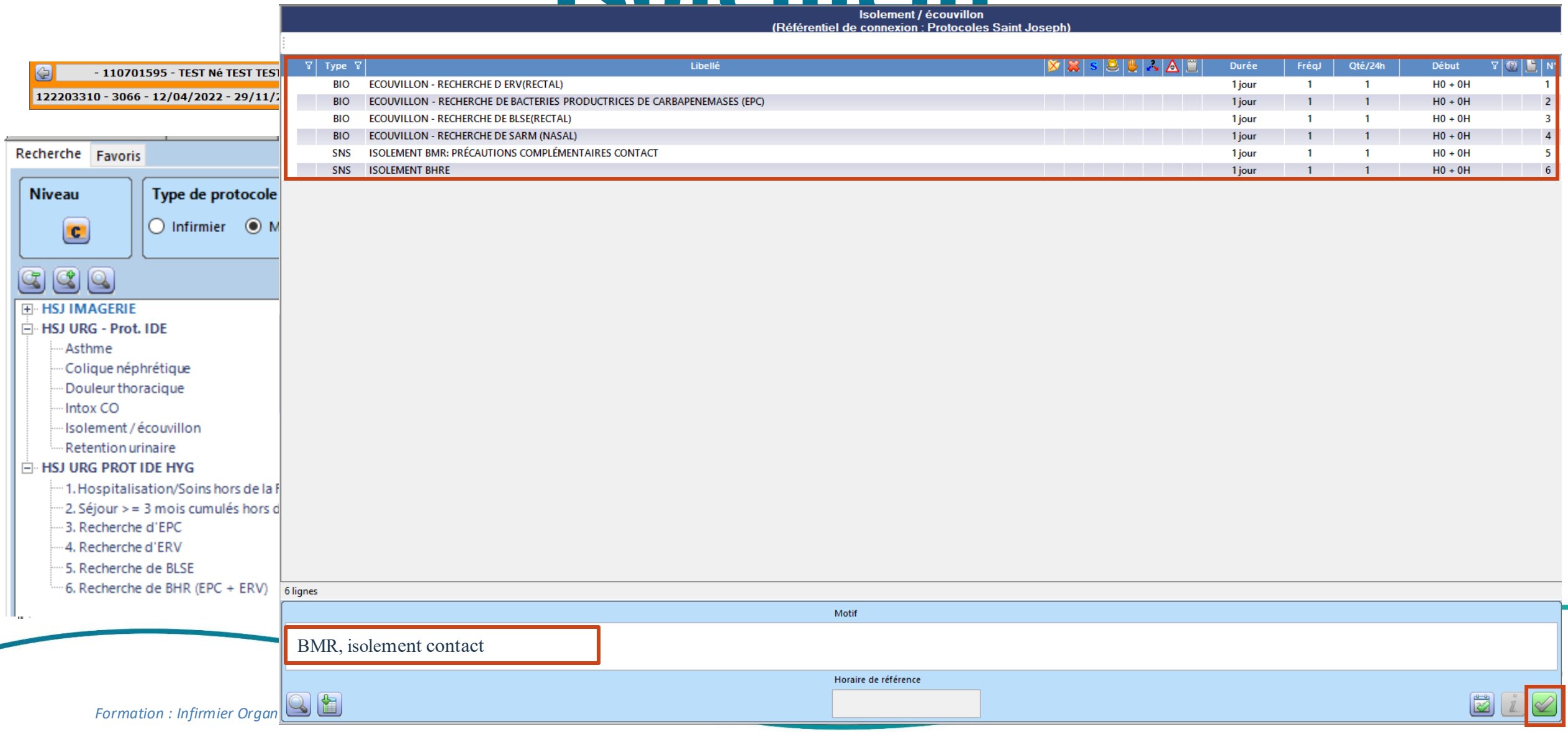
Douleur


Surveillance intensité douleur: autres éc
Echelle Visuelle Analogique (EVA)
EN / 10
Echelle verbale simple = EVS
EVS
0 - A
1 - D
2 - D
3 - D
4 - D
Réévaluation douleur : 1h apres administration d'antalgique à 09h
Intervention
Réévaluation douleur
Paramètre
1h apres administration d'antalgique
Pendant
1
jours, du
08/02/2024
09:00
au
09/02/2024
08:59
Planification :
Horaire
Fréq. horaire :
Détails - Horaire
Calendaire
Fréq. jour
1
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
X
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
Nombre d'actes / 24H
1
Paramètres max des actes
Durée max :
Nbre d'actes max :
Commentaires
Statut
En cours

Isolement

- Ouvrir le dossier du patient, ou regarder dans la liste si isolement
- Si isolement ou EPC/ERV/BLSE/SARM à dépister → prescrire l'isolement / les écouvillons dès l'IOA
- Patient BHRe = isolement en box (matériel dans le box + IOA dans le box de zone)
  Si possible, même IDE qui fait IOA et les soins.
- Si voyage de + de 3 mois à l'étranger ou soins/hospitalisation à l'étranger =
  Isolement contact + Dépistage SARM, EPC, ERV, et BLSE.

Isolement


- 110701595 - TEST Né TEST TEST
122203310 - 3066 - 12/04/2022 - 29/11/
Recherche
Favoris
Niveau
Type de protocole
Infirmier
HSJ IMAGERIE
HSJ URG - Prot. IDE
Asthme
Colique néphrétique
Douleur thoracique
Intox CO
Isolement / écouvillon
Retention urinaire
HSJ URG PROT IDE HYG
1. Hospitalisation/Soins hors de la
2. Séjour > = 3 mois cumulés hors
3. Recherche d'EPC
4. Recherche d'ERV
5. Recherche de BLSE
6. Recherche de BHR (EPC + ERV)
Isolement / écouvillon
(Référentiel de connexion : Protocoles Saint Joseph)
Type
Libellé
Durée
FréqJ
Qté/24h
Début
BIO ECOUVILLON - RECHERCHE D ERV(RECTAL) 1 jour 1 1 H0 + 0H 1
BIO ECOUVILLON - RECHERCHE DE BACTERIES PRODUCTRICES DE CARBAPENEMASES (EPC) 1 jour 1 1 H0 + 0H 2
BIO ECOUVILLON - RECHERCHE DE BLSE(RECTAL) 1 jour 1 1 H0 + 0H 3
BIO ECOUVILLON - RECHERCHE DE SARM (NASAL) 1 jour 1 1 H0 + 0H 4
SNS ISOLEMENT BMR: PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES CONTACT 1 jour 1 1 H0 + 0H 5
SNS ISOLEMENT BHRE 1 jour 1 1 H0 + 0H 6
6 lignes
Motif
BMR, isolement contact
Horaire de référence

2. Rappels médico-légaux

Rappels médico-légaux : Réorientation

- Appel au MAO avant réorientation obligatoire
- Noter le nom du médecin qui valide la réorientation + lieu de réorientation
- Tout patient réorienter doit avoir un motif IOA
- Les patients < 16 ans = IOA + Avis médecin avant réorientation
- Proctologie = seules les hémorroïdes objectivées à l'IOA peuvent être réorientés.
  NE PAS DONNER DE XYLOCAINE aux patients.

Rappels médico-légaux : Patient mineur

- Patient mineur entre 16 et 18 ans
- Doivent être accompagné d'un majeur obligatoirement
- Isolement en box
- Autorisation de soins signé obligatoirement par les parents + scanner dans le dossier dès l'IOA.
  Si parents non présents, prévenir encadrement + demandé aux parents d'envoyer un mail donnant l'autorisation de soins.
  Je soussigne ….

Rappels médico-légaux : CNA

- Demander le motif de la consultation à la police

- Si patient calme et coopérant, demander à la police de patienter en dehors du box
  → Secret professionnel.
  → Police à chaque porte IOA + Agent de sécurité à la porte vitrée

- Après évaluation → Appel MAO pour prévenir du CNA + Isolement en box (ou installation box MAO ou IOA 3)

- Si patient présente un risque pour le soignant, autorisation qu'un agent de police vous accompagne dans le box.
  Pas de question portant au secret professionnel.

Rappels médico-légaux : Fugue / Sortie à l'insu du service

- Attention à la différence : 2 procédures différentes.

- Fugue = Danger pour le patient
  - Remplir la fiche fugue dans le recueil soignant
    - Prévenir Encadrement
      - Transmission dans le dossier patient + FEI

- Sortie à l'insu du service = Pas de danger pour le patient
  - Remplir la fiche sortie à l'insu du service dans le recueil soignant

Si vous constatez une disparition (voir avec médecin pour statuer si fugue ou sortie).
Prévenir agent de sécurité SAU + recherche dans le service.
Appel du patient sur son numéro de téléphone.
Prévenir sécurité de l'hôpital

3. Table ronde